

Memoria académica

1. Ficha Técnica

Título del Programa:

State of the Art in Atopic Dermatitis: Self-Assessment Program.

Entidad Organizadora / Proveedor Educativo:

Hygeia Learning Hub.

Fuente Científica Exclusiva:

Contenidos extraídos y adaptados de las publicaciones oficiales de la British Association of Dermatologists (BAD): British Journal of Dermatology (BJD), Clinical and Experimental Dermatology (CED) y Skin Health and Disease (SHD). Además de otros contenidos multimedia de BAD.

Modalidad de Impartición:

Formación 100% Online (E-learning interactivo) + Webinar de Apertura en Directo.

Fechas Previstas de Edición:

De Octubre 2026 a Mayo 2027 (Plataforma abierta durante 8 meses).

Acreditación Solicitada:

Créditos de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud (SNS) para las profesiones sanitarias.

Avales Científicos Solicitados:

- Sociedad Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Patrocinio / Soporte Educativo (Unrestricted Educational Grant):

Programa financiado a través de una beca formativa no condicionada.: Las entidades patrocinadoras no intervendrán en el diseño pedagógico, ni en la selección de los autores, ni en el contenido científico independiente del programa.

2. Presentación del curso:

El programa formativo "State of the Art in Atopic Dermatitis: Self-Assessment Program" nace como una iniciativa de excelencia médica impulsada por Hygeia Learning Hub. Se trata de un curso de actualización avanzada, estructurado en formato e-learning interactivo, diseñado para acompañar al especialista en dermatología en uno de los cambios de paradigma más relevantes de la especialidad: la transición de un enfoque clínico centrado tradicionalmente en la inflamación y el eritema, hacia la comprensión y modulación del eje neuroinmune y el control rápido del prurito.

A través de una rigurosa curaduría de literatura científica y material multimedia (vídeos, infografías y podcasts) proveniente de las revistas oficiales de la British Association of Dermatologists (BAD), el programa articula un currículum de tres módulos que abarca desde la fisiopatología de la interleucina-31 (IL-31), pasando por el posicionamiento de las nuevas terapias sistémicas dirigidas, hasta culminar en el impacto humanístico que el insomnio y la carga de la enfermedad (burden of disease) tienen sobre la biografía del paciente.

El curso se inaugurará con un Seminario Web (Kick-off) de alto nivel científico, y se desarrollará bajo una metodología altamente pragmática basada en Casos Clínicos, Critical Debates y herramientas de aplicabilidad real en consulta (Practice Insights), exigiendo una autoevaluación constante (Self-Assessment) por parte del alumno para la obtención de la certificación y los créditos CFC.

3. Justificación de la actividad

El manejo clínico de la Dermatitis Atópica (DA) de moderada a grave se encuentra en un momento de profunda transformación. A pesar de los indudables avances logrados en los últimos años con el advenimiento de los primeros fármacos biológicos y los inhibidores de la vía JAK-STAT, el prurito crónico severo y el insomnio secundario siguen representando una necesidad médica no cubierta en un amplio subgrupo de pacientes. Este cuadro sintomatológico es el principal responsable de la saturación de las consultas por parte del "paciente policonsultador", un perfil caracterizado por el agotamiento físico, la frustración y una grave alteración de su calidad de vida y productividad laboral.

En este contexto, la modulación del eje neuroinmune cutáneo, y en particular la inhibición del receptor alfa de la interleucina-31 (IL-31RA), emerge como un paradigma terapéutico disruptivo. Las nuevas evidencias de fase 3 demuestran que es posible escindir y bloquear de forma selectiva y rápida el ciclo picor-rascado, logrando un impacto temprano (desde la primera semana de tratamiento) en el descanso nocturno del paciente, con un perfil de seguridad favorable que no exige la monitorización analítica intensiva asociada a otras terapias sistémicas.

La irrupción de estas terapias dirigidas exige que el dermatólogo actualice sus competencias en tres dimensiones críticas, las cuales justifican el desarrollo integral de este programa:

- **Dimensión Fisiopatológica:** La medicina traslacional actual requiere que el clínico comprenda la neuroinmunología de la piel; reconociendo cómo citoquinas específicas (como la IL-31) actúan como puente directo entre el sistema inmunitario y las terminaciones nerviosas periféricas, perpetuando la inflamación y la fibrosis.
- **Dimensión Clínica y Terapéutica:** Resulta imperativo dominar el nuevo algoritmo terapéutico sistémico. El especialista debe aprender a analizar de forma crítica los ensayos clínicos recientes, diferenciando los perfiles de eficacia y seguridad de las distintas familias de biológicos y moléculas pequeñas. Esto le permitirá seleccionar el tratamiento idóneo basándose en el fenotipo del paciente (ej. predominio de prurito intenso) y sus comorbilidades.
- **Dimensión Humanista e Integral:** La reducción de la carga de la enfermedad exige repensar la evaluación en consulta. El especialista necesita incorporar herramientas de medición de resultados reportados por el paciente (PROMs) como el PP-NRS (intensidad del prurito) y el SD-NRS (alteración del sueño). Dominar estas soft skills y protocolos de comunicación empática es vital para abordar el "Dolor Total" (Total Pain) biopsicosocial del paciente y restaurar la alianza terapéutica.

Por todo ello, la presente actividad formativa es indispensable para garantizar que los dermatólogos del Sistema Nacional de Salud dispongan de la capacitación científica y las herramientas clínicas necesarias para liderar esta nueva era en el tratamiento integral y humanizado de la Dermatitis Atópica.

4. Objetivos de la actividad

4.1 Objetivo General

Capacitar al especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica en el manejo clínico integral de la Dermatitis Atópica bajo el nuevo paradigma del eje neuroinmune, dotándole de las herramientas necesarias para integrar las terapias biológicas dirigidas con un enfoque humanista centrado en el control rápido del prurito, la resolución del insomnio y la restauración de la calidad de vida del paciente.

4.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, el programa plantea la adquisición de las siguientes competencias específicas, agrupadas en tres grandes dimensiones:

- De conocimiento fisiopatológico (El Eje Neuroinmune):
 - Comprender la interacción bidireccional entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso periférico en la patogenia de la Dermatitis Atópica.
 - Identificar el papel fisiopatológico de la interleucina-31 (IL-31) y su receptor (IL-31RA) como mediadores clave en la perpetuación del ciclo picor-rascado, la alteración de la barrera cutánea y la inflamación crónica.
- De manejo clínico y terapéutico (Terapias Dirigidas):
 - Analizar la eficacia, seguridad y rapidez de acción de los nuevos anticuerpos monoclonales y terapias de pequeñas moléculas basándose en la última evidencia de ensayos pivotaes de fase 3.
 - Diferenciar los perfiles de seguridad a corto y largo plazo entre las distintas familias terapéuticas (inhibidores de IL-4/13, IL-13, IL-31 e inhibidores JAK), optimizando la monitorización clínica del paciente.
 - Aplicar algoritmos de decisión clínica basados en fenotipos (ej. predominancia de prurito severo refractario) para realizar una selección y secuenciación terapéutica personalizada y eficiente.
- De habilidades humanísticas y comunicación (Soft Skills y PROMs):
 - Incorporar de forma sistemática y ágil en la consulta el uso de métricas de resultados reportados por los pacientes (PROMs), como la escala de prurito máximo (PP-NRS) y la escala de alteración del sueño (SD-NRS).
 - Aplicar estrategias de comunicación avanzada y empatía clínica para abordar la carga biopsicosocial y el "Dolor Total" del paciente policonsultador, mitigando la frustración derivada del fallo terapéutico previo.
 - Fomentar el modelo de Toma de Decisiones Compartida (SDM), haciendo partícipe al paciente en la elección de su terapia mediante el manejo adecuado de las expectativas en cuanto a los tiempos de aclaramiento de lesiones frente al alivio rápido de los síntomas invisibles (picor y falta de sueño).

5. Estructura y Contenidos Académicos

El programa se estructura en tres módulos principales, diseñados bajo un modelo de aprendizaje progresivo. Cada módulo garantiza la adquisición integral de competencias mediante un diseño instruccional estandarizado (UX) compuesto por 8 apartados pedagógicos de obligado cumplimiento para el alumno.

Módulo 1: El Eje Neuroinmune en la Dermatitis Atópica: Fisiopatología del Prurito y la Vía de la IL-31

Objetivo del Módulo: Profundizar en el paisaje molecular actual, evolucionando desde la inflamación clásica tipo 2 hacia la comprensión integral del papel de la IL-31 como puente entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso periférico.

- **Executive Brief (Podcast):** "La citocina del prurito: Cómo la IL-31 conecta la inmunidad con las terminaciones nerviosas y perpetúa la inflamación".
- **Scientific Core:** Artículos completos (Full-text) extraídos del British Journal of Dermatology (BJD) sobre la fisiopatología de la barrera cutánea y el bloqueo selectivo del receptor alfa de la interleucina-31 (IL-31RA).
- **Critical Debate:** Artículo de revisión (Skin Health and Disease): "Desafíos diagnósticos: ¿Es el prurito un síntoma secundario o el motor principal de la cronicidad en la Dermatitis Atópica?".
- **Further readings:** Resúmenes breves con enlaces directos a PubMed sobre consensos europeos de fenotipificación clínica.
- **Practice Insights:** Algoritmo de consulta para identificar rápidamente a los pacientes con un perfil clínico de gravedad impulsado predominantemente por el prurito (PP-NRS ≥ 7).
- **Clinical Cases:** Caso clínico interactivo (Clinical and Experimental Dermatology) centrado en un paciente adolescente con eccema moderado (IGA 3) pero con prurito severo e incapacitante.
- **Self-Assessment:** Cuestionario formativo (10 preguntas tipo test con feedback razonado) sobre vías de señalización e interleucinas diana.
- **Multimedia:** Infografía dinámica y animada que ilustra el mecanismo neuroinmune en el epitelio y la dermis papilar, mostrando el ciclo picor-rascado a nivel celular.

Módulo 2. Paradigmas Emergentes en el Tratamiento Sistémico: Terapias Dirigidas y el Control Rápido del Prurito

Objetivo del Módulo: Analizar exhaustivamente la evidencia científica reciente sobre el posicionamiento de los anticuerpos monoclonales y los inhibidores JAK, con especial énfasis en la rapidez de acción como nuevo estándar de eficacia.

- **Executive Brief (Podcast):** "La era de la precisión en Dermatología: Rapidez de acción, mantenimiento y perfiles de seguridad en las nuevas terapias sistémicas".
- **Scientific Core:** Análisis desglosado de los resultados de ensayos clínicos controlados de fase 3, destacando la consecución de respuestas EASI-75 y la reducción significativa y rápida del prurito (PP-NRS ≥ 4) desde las primeras semanas.
- **Critical Debate:** "Perfil de seguridad comparado en la práctica real: Biológicos (IL-4/13, IL-13, IL-31) frente a inhibidores JAK (iJAK)". Análisis del riesgo/beneficio y la

optimización de recursos (ausencia de requerimiento de monitorización analítica intensiva en terapias biológicas).

- **Further readings:** Bibliografía seleccionada del BJD sobre los eventos adversos de especial interés (AESI), analizando la ausencia de señales oftalmológicas asociadas a la inhibición selectiva de la IL-31.
- **Practice Insights:** Guía pragmática (CED) con criterios de dosificación, inducción y transición a regímenes de mantenimiento espaciados (ej. cada 8 semanas) en pacientes respondedores.
- **Clinical Cases:** Manejo de un paciente adulto refractario a ciclosporina A, con factores de riesgo cardiovascular asociados, candidato a terapia biológica dirigida.
- **Self-Assessment:** Cuestionario formativo sobre los hitos de eficacia (EASI, IGA, PP-NRS) y algoritmos de seguridad de los tratamientos actuales.
- **Multimedia:** Animación médica interactiva sobre el algoritmo de decisión clínica terapéutica adaptado a las guías internacionales recientes.

Módulo 3. Humanización y PROMs: El Impacto Oculto del Insomnio y la Gestión Integral del Paciente

Objetivo del Módulo: Integrar la medición de la calidad de vida y los Patient-Reported Outcomes (PROMs) dentro de un modelo de cuidado centrado en la empatía clínica y la reducción del impacto biopsicosocial.

- **Executive Brief (Podcast):** "Más allá de la piel: El impacto del insomnio, la ansiedad y el agotamiento en el paciente atópico".
- **Scientific Core:** Selección de artículos (Skin Health and Disease) enfocados en el impacto directo del prurito nocturno en la interrupción del sueño y el aumento del riesgo de trastornos del estado de ánimo.
- **Critical Debate:** "Nuevos retos en la consulta saturada: ¿Cómo integrar de forma eficiente herramientas de medición del sueño (SD-NRS) y calidad de vida (DLQI) en la práctica diaria?".
- **Further readings:** Enlaces a recursos sobre Medicina Narrativa aplicados a la dermatología y el manejo del "Dolor Total" (Total Pain).
- **Practice Insights:** Protocolos de comunicación empática (CED): Cómo abordar y gestionar las expectativas del paciente respecto a la rapidez del alivio sintomático frente al aclaramiento a largo plazo de las lesiones.
- **Clinical Cases:** Caso narrativo inmersivo: El acompañamiento de un "paciente policonsultador" cuyo mayor motivo de sufrimiento es la privación crónica de sueño y la pérdida de productividad laboral. Enfoque en la recuperación de la confianza médico-paciente.
- **Self-Assessment:** Cuestionario práctico sobre la aplicación de métricas de calidad de vida y habilidades de comunicación clínica (Soft Skills).

- **Multimedia:** Entrevista clínica simulada en vídeo demostrando la aplicación práctica de escalas PROMs en menos de 3 minutos.

6. Dirección Académica e Institucional

Editor en Jefe del Programa y Editor Módulo 1. El Eje Neuroinmune en la Dermatitis Atópica: Fisiopatología del Prurito y la Vía de la IL-31

Dr. Juan Francisco Silvestre Salvador

Jefe de Servicio de Dermatología
Servicio de Dermatología
Hospital General Universitario de Alicante

Editor Módulo 2. Paradigmas Emergentes en el Tratamiento Sistémico: Terapias Dirigidas y el Control Rápido del Prurito

Dr. José Carlos Armario Hita

Jefe de Servicio de Dermatología
Servicio de Dermatología
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz

Editor Módulo 3. Humanización y PROMs: El Impacto Oculto del Insomnio y la Gestión Integral del Paciente

Dra. Esther Serra-Baldrich

Especialista senior en Dermatología
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

7. Público Objetivo

El programa "State of the Art in Atopic Dermatitis" está diseñado específicamente para facultativos médicos directamente implicados en el diagnóstico, prescripción de tratamientos y seguimiento a largo plazo de pacientes con Dermatitis Atópica (DA) de moderada a grave.

Perfil del Participante (Licenciados/Graduados en Medicina):

- Especialistas en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología: Como prescriptores principales y responsables del algoritmo terapéutico sistémico del paciente atópico.
- Médicos Internos Residentes (MIR) de la especialidad de Dermatología: Especialmente aquellos en sus últimos años de formación (R3-R4), para quienes la

comprensión del eje neuroinmune y las nuevas terapias biológicas es crítica para su futura práctica asistencial.

- Especialistas en Alergología e Inmunología Clínica: Dado el componente sistémico de la inflamación tipo 2 y el solapamiento frecuente de patologías atópicas que requieren un manejo clínico coordinado.
- Especialistas en Pediatría (Dermatología Pediátrica): Debido a la indicación de las nuevas terapias dirigidas en población adolescente (a partir de 12 años) y la necesidad de gestionar las expectativas de las familias en casos refractarios.

8. Metodología y Sistema de Evaluación

8.1. Metodología Docente (UX y Navegación)

El curso se aloja en un entorno virtual de aprendizaje (LMS) avanzado, accesible desde cualquier dispositivo (diseño responsive). La metodología es asíncrona, permitiendo al especialista conciliar la formación con su carga asistencial.

Para garantizar la asimilación progresiva, la plataforma exige un flujo de navegación secuencial: el alumno no podrá acceder al examen final sin haber visualizado previamente el 100% de los contenidos de los tres módulos y superado las evaluaciones formativas intermedias (Self-Assessments).

8.2. Sistema de Evaluación Integral

El programa implementa un doble sistema de evaluación para certificar la adquisición de competencias, cumpliendo con los estándares de la Comisión de Formación Continuada:

Evaluación Formativa Continua (Self-Assessments):

- Al finalizar cada módulo, el alumno deberá completar un cuestionario interactivo de 10 preguntas tipo test.
- Cada respuesta (correcta o incorrecta) ofrece un feedback razonado de forma inmediata, referenciando la literatura del Syllabus, lo que consolida el aprendizaje a través del ensayo-error.

Evaluación Sumativa Final:

- Al concluir el tercer módulo, se desbloqueará el Examen Final Online.
- Constará de 30 preguntas de opción múltiple con respuesta única (10 preguntas extraídas aleatoriamente de la base de datos de cada módulo).
- Criterios de superación: Será necesario obtener al menos un 80% de aciertos para aprobar. El alumno dispondrá de un máximo de 2 intentos para superar esta prueba.

Encuesta de Calidad y Satisfacción:

Una vez superado el examen, será requisito indispensable cumplimentar una encuesta de satisfacción anónima valorando la calidad científica, la labor de los autores y la plataforma técnica.

Acreditación y Diplomas:

Tras cumplir todos los requisitos anteriores, la plataforma habilitará la descarga automática y segura (con código de verificación) del Diploma Acreditativo, donde constarán explícitamente los logotipos de los avales científicos (SEHH / SETH) y los Créditos de Formación Continuada (CFC) concedidos por el SNS.